

NEUROSURV

Surveillance des maladies infectieuses neurologiques en Belgique

Rapport annuel 2025

Avril 2026

G. STEFANI • T. LERNOUT

REMERCIEMENTS

Le service d'épidémiologie des maladies infectieuses de Sciensano tient à remercier tous les cliniciens participant au système de surveillance NeuroSurv, ainsi que les membres du comité de suivi scientifique, pour leur précieuse contribution.

Avec l'aide financière de



Merci de citer cette publication comme suit : Stefani G, Lernout T. Surveillance des maladies infectieuses neurologiques en Belgique. Rapport annuel – 2025. Bruxelles, Belgique : Sciensano ; 2026. Numéro de rapport D/2026.14.440/42

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	4
2. Méthode	5
3. Résultats	6
3.1. Participation	6
3.2. Neuroborréliose de Lyme	8
3.3. Encéphalite à tiques	11
3.4. Paralyse flasque aiguë.....	11
Discussion	12
Références	13
Annexe 1 – Définitions de cas	14

1. Introduction

La surveillance des maladies infectieuses en Belgique est assurée par différents systèmes, tels que la déclaration obligatoire, la surveillance en laboratoire (Centres Nationaux de référence et réseau de laboratoires vigies) et un réseau de médecins généralistes vigies.

La déclaration des cas de neuroborréliose de Lyme (NBL), basée sur une définition de cas de l'Union Européenne (UE), est obligatoire en Europe depuis 2019 (Annexe 1). Cependant, en l'absence d'un système de surveillance adapté, la Belgique ne pouvait répondre à cette demande de déclaration au niveau européen.

Dès lors, un système de surveillance pour les maladies neuroinfectieuses, NeuroSurv, a été mis en place en janvier 2024, basé sur la participation volontaire de neurologues et de neuropédiatres. Le réseau permet de collecter des données agrégées sur la NBL, afin de les communiquer au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

En plus de la NBL, le réseau offre la possibilité de recueillir des données sur d'autres infections neurologiques pour lesquelles le fardeau de maladie réelle pourrait être sous-estimé par les systèmes de surveillance actuels. En 2024 et 2025, des données ont ainsi été collectées sur l'encéphalite à tiques (TBE) et la paralysie flasque aiguë (PFA). À l'avenir, la surveillance pourrait être étendue à d'autres maladies ou syndromes neuroinfectieux.

La neuroborréliose de Lyme (NBL)

La NBL est la seule manifestation de la borréliose de Lyme (BL) pour laquelle il existe une définition de cas claire qui peut être appliquée de manière homogène dans les États membres de l'UE. Le nombre attendu de cas annuels est également suffisamment faible pour permettre une surveillance exhaustive (contrairement à l'érythème migrant, la manifestation la plus fréquente de la BL). Depuis 2019, l'ECDC a introduit la surveillance de la NBL comme outil privilégié pour évaluer le fardeau de maladie de la BL en Europe, dans le but de pouvoir comparer les données dans les pays de l'UE (1,2).

Le diagnostic de la NBL repose sur les symptômes cliniques ainsi que sur des analyses en laboratoire, à partir de prélèvements sanguins et de liquide céphalo-rachidien (LCR). Il est donc nécessaire de combiner les données du médecin traitant, du laboratoire général (pléiocytose) et du laboratoire de microbiologie (3–5). C'est en partie à cause de cette complexité du diagnostic de la NBL que les réseaux de surveillance existants n'étaient pas en mesure d'estimer et de suivre le nombre de cas de NBL en Belgique. La surveillance de BLborréliose de Lyme est toutefois assurée par d'autres systèmes de surveillance et d'études scientifiques. Ainsi, une étude basée sur les données de la période 2015-2017 a estimé l'incidence de la NBL en Belgique à 2,4/100 000 habitants (95% IC 1,5-3,7), ce qui correspond à environ 270 cas de NBL par an (6). Plus d'information sur les données les plus récentes relatives à la borréliose de Lyme est disponible [ici](#).

Encéphalite à tiques (TBE)

L'encéphalite à tiques est considérée comme une maladie émergente en Europe en raison de son incidence croissante et de son expansion dans de nouvelles zones, auparavant non infectées (7). En Belgique, la surveillance de la TBE chez l'homme est basée sur la déclaration des cas confirmés par le Centre National de Référence (Institut de Médecine Tropicale). En 2025, la TBE a également été ajoutée à la liste des maladies à déclaration obligatoire en Flandre. Les deux premiers cas probablement autochtones d'encéphalite à tiques ont été déclarés en 2018, suivis de trois autres cas déclarés en 2020, ayant été infectés avec certitude en Belgique (8,9). Cependant, on soupçonne un sous-diagnostic des cas humains, car les infections légères ne sont probablement pas diagnostiquées et les examens de laboratoire pour une encéphalite virale sont généralement limités. Des études de séroprévalence chez l'animal ont montré que le virus circule en Belgique depuis de nombreuses années. Selon l'animal et la période étudiée, différents taux de prévalence ont été rapportés, allant de 0,11 % chez les chiens en 2009 (Belgique) à 9,27 % chez les sangliers en 2019/2020 (Flandre) (10–12).

En plus de la surveillance chez les animaux, le renforcement de la surveillance de l'encéphalite à tiques chez l'homme par les neurologues via NeuroSurv (ce qui permettra notamment de les sensibiliser à la maladie) devrait aider à mieux comprendre et évaluer le risque humain de l'encéphalite à tiques en Belgique. Plus d'information sur les données les plus récentes relatives à la TBE est disponible [ici](#).

Paralysie flasque aiguë (PFA)

Bien que le poliovirus ait été éradiqué en Belgique depuis 2002, le risque de réintroduction a été évalué par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme étant « intermédiaire », principalement en raison d'une surveillance insuffisante.

La polio est une urgence de santé publique de portée internationale (Public health emergency of international concern, PHEIC) en raison de l'augmentation du nombre de cas de poliovirus circulant dérivé d'un vaccin (PVDVc) au cours des dernières années, en particulier dans des régions qui étaient auparavant considérées comme "exemptes de polio".

La surveillance du poliovirus en Belgique est basée sur la surveillance des PFA, complétée par la surveillance des eaux usées et des entérovirus. Tous les cas de PFA chez les personnes de moins de 15 ans, quelle qu'en soit la cause, doivent obligatoirement être notifiés. Une analyse de laboratoire (deux échantillons de selles, à un intervalle de plus de 24 heures, envoyés au CNR pour entérovirus à l'UZ Leuven) est nécessaire pour confirmer que le cas n'est pas causé par le poliovirus. Pour démontrer que ce système capture tous les cas de PFA, environ 19 cas par an devraient être notifiés en Belgique, équivalant à un cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans. Malheureusement, depuis le début de la surveillance, la Belgique n'a pas été en mesure d'atteindre cet objectif. L'amélioration de la surveillance de la PFA en Belgique et la sensibilisation des cliniciens à la déclaration sont essentielles. En particulier, les neurologues pédiatriques ont une probabilité plus élevée de rencontrer des cas de PFA chez les moins de 15 ans. Plus d'information sur les données les plus récentes relatives à la PFA est disponible [ici](#).

2. Méthode

Fin 2023, tous les services de neurologie et de neurologie pédiatrique des hôpitaux des trois régions belges ont été invités par courriel et/ou par téléphone, pour participer à NeuroSurv, avec la demande de proposer un participant comme représentant de l'ensemble du service. En 2024 et 2025, l'ensemble des services a été recontacté pour essayer d'améliorer le taux de participation et de recruter de nouveaux participants.

Chaque mois, les participants inscrits reçoivent un lien vers un questionnaire dans LimeSurvey, qui permet de collecter des données agrégées sur les maladies incluses dans la surveillance. S'il n'y a pas eu de cas à déclarer au cours du mois écoulé, il faut également le signaler ("zéro cas").

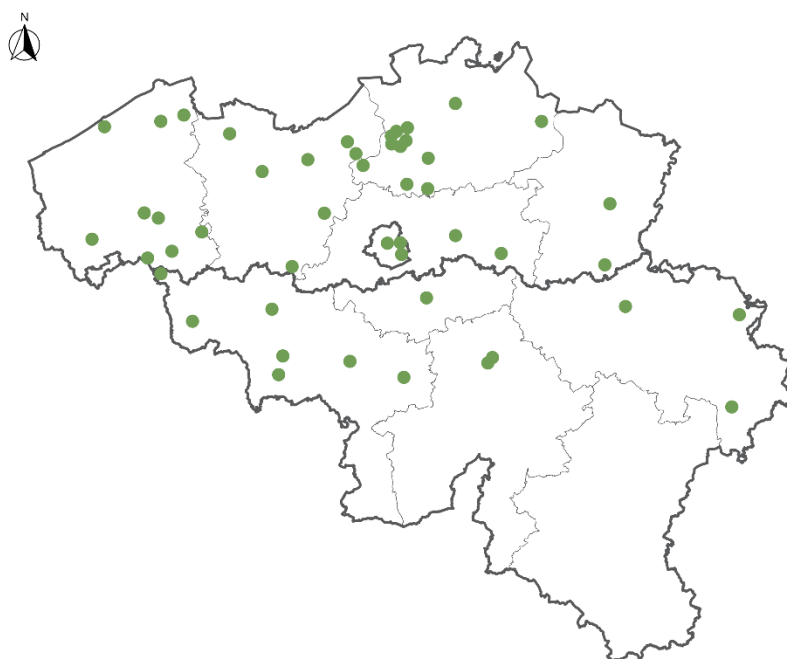
La liste des maladies sous surveillance est révisée chaque année par un comité de suivi scientifique composé de représentants des autorités sanitaires régionales, de neurologues, de neuropédiatres, d'infectiologues et des épidémiologistes de Sciensano.

3. Résultats

3.1. Participation

Le nombre de cliniciens participants a augmenté au cours de l'année 2025, passant de 48 en janvier à 51 en octobre. Les 51 cliniciens participants représentaient 48 hôpitaux différents¹, sur un total de 121 hôpitaux contactés (40 %), répartis dans les trois régions (30 hôpitaux en Flandre, 15 en Wallonie et trois à Bruxelles). Comme le montre la Figure 1, il y a moins d'hôpitaux participants dans le sud de la Belgique, où il y a également moins d'hôpitaux².

Figure 1 : Répartition géographique des hôpitaux participant à NeuroSurv



En 2025, un total de 278 participations complètes a été enregistré sur 599 sollicitations mensuelles envoyées, correspondant à un taux global de participation de 46 %. Le nombre de cliniciens participants par mois, rapportant au moins un cas ou zéro cas, a varié de 6 (en septembre et en décembre) à 30 (en janvier) avec une moyenne de 23 (Figure 2). Ceci est légèrement inférieur à la participation moyenne en 2024 (26 par mois), malgré un nombre de participants inscrits plus élevé.

Parmi les 278 participations enregistrées en 2025, 244 (88 %) correspondaient à une notification de « zéro cas » (Figure 2).

¹ Un hôpital peut inclure différents participants, issus de différents services au sein de l'hôpital (par exemple, neurologie et neurologie pédiatrique) ou de différents sites au sein d'un même consortium.

² [Liste des institutions de soins en Belgique | SPF Santé publique.](#)

Figure 2 : Nombre de participants par mois (déclaration de « zéro cas » ou d'au moins un cas), 2025

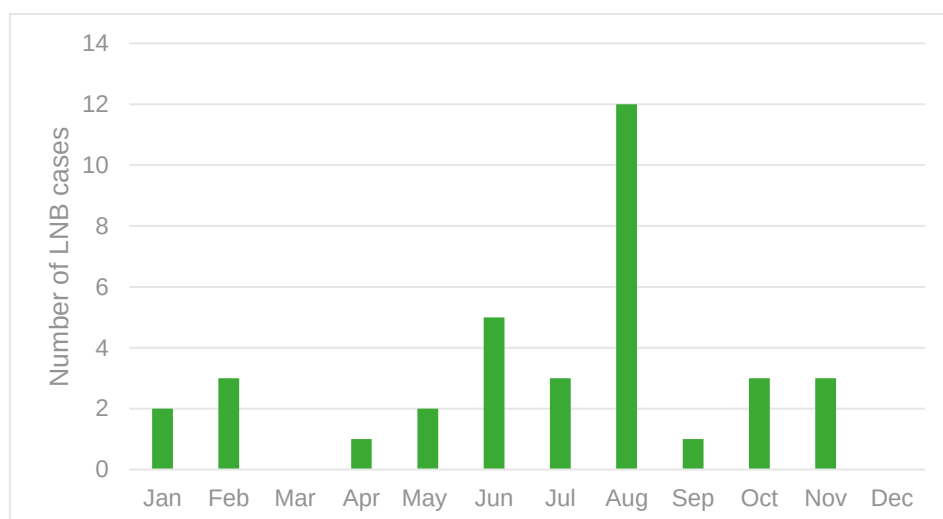


3.2. Neuroborréliose de Lyme

En 2025, 35 cas de NBL ont été signalés par 17 participants différents répartis sur l'ensemble du pays, dont quatre en Wallonie, onze en Flandre et deux à Bruxelles.

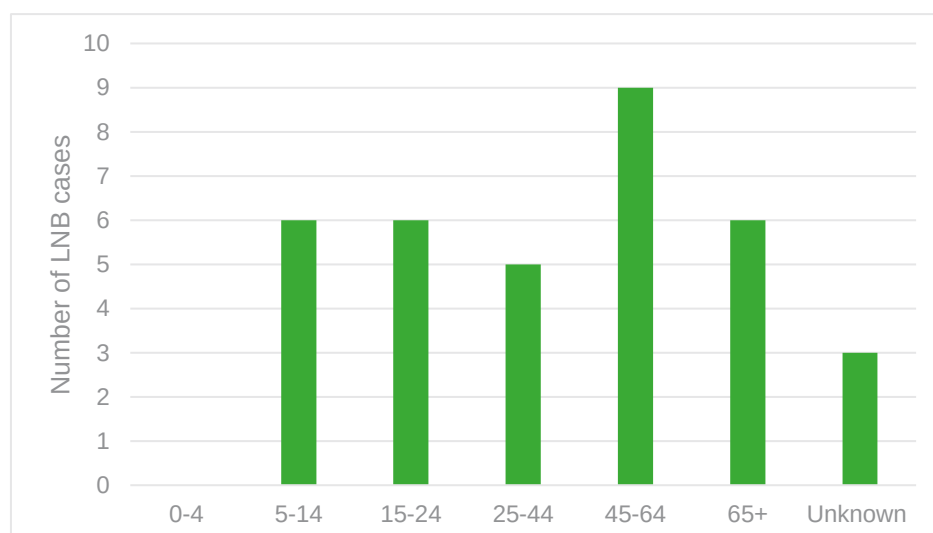
Des cas ont été signalés tout au long de l'année, avec un pic observé durant les mois d'été, particulièrement en août ($n = 12$) (Figure 3). Cette distribution saisonnière peut être liée au risque plus élevé de morsures de tiques durant le printemps et l'été, bien que la NBL peut se manifester des semaines ou des mois après une morsure de tique, et ne survient donc pas nécessairement toujours pendant la saison des morsures de tiques (13).

Figure 3 : Nombre de cas de NBL signalés par mois, 2025



Le nombre le plus élevé de cas a été enregistré dans le groupe d'âge de 45 à 65 ans ($n = 9$) (Figure 4). Au total, 43 % des cas ($n = 15$) en 2025 avaient 45 ans ou plus. Plus de la moitié des cas étaient des hommes ($n = 21$, 60 %).

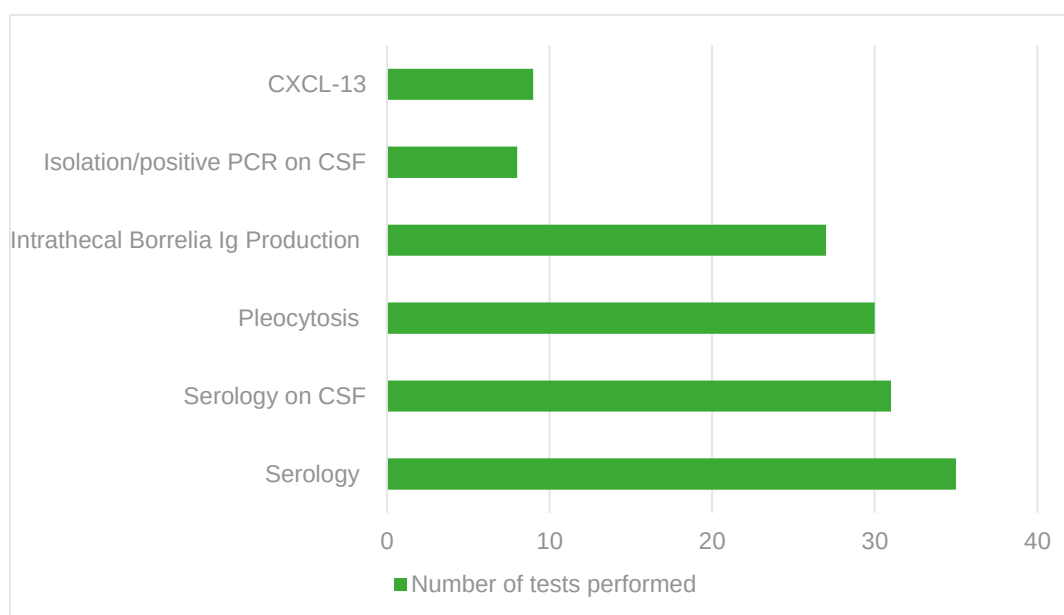
Figure 4 : Nombre de cas de NBL signalés par groupe d'âge, 2025



Différentes méthodes de laboratoire ont été utilisées pour le diagnostic (Figure 5). Selon la définition de cas de l'UE d'un cas confirmé ou probable, le diagnostic repose sur une ponction lombaire afin de mettre en évidence une pléiocytose et de démontrer une production intrathécale d'anticorps de *Borrelia* (d'où la nécessité d'un test sérologique sur le sang et sur le LCR). Contrairement à 2024, les données collectées en 2025 permettaient de distinguer la réalisation des examens et leurs résultats.

En 2025, une ponction lombaire a été effectuée pour 31 des 35 cas rapportés (89 %) ; la pléiocytose a été confirmée chez 28 patients, tandis que la production intrathécale d'anticorps a été démontrée chez 22 patients³. La détermination du taux de CXCL13, utilisée en complément de la sérologie dans le diagnostic de la NBL, a été réalisée chez neuf patients dont six se sont avérés positifs. Sur cette base, 27 des 35 cas (77 %) ont été diagnostiqués selon les critères de définition de cas de l'ECDC pour les cas confirmés ou probables (Annexe 1).

Figure 5 : Type de tests de diagnostic utilisés pour la NBL, 2025³



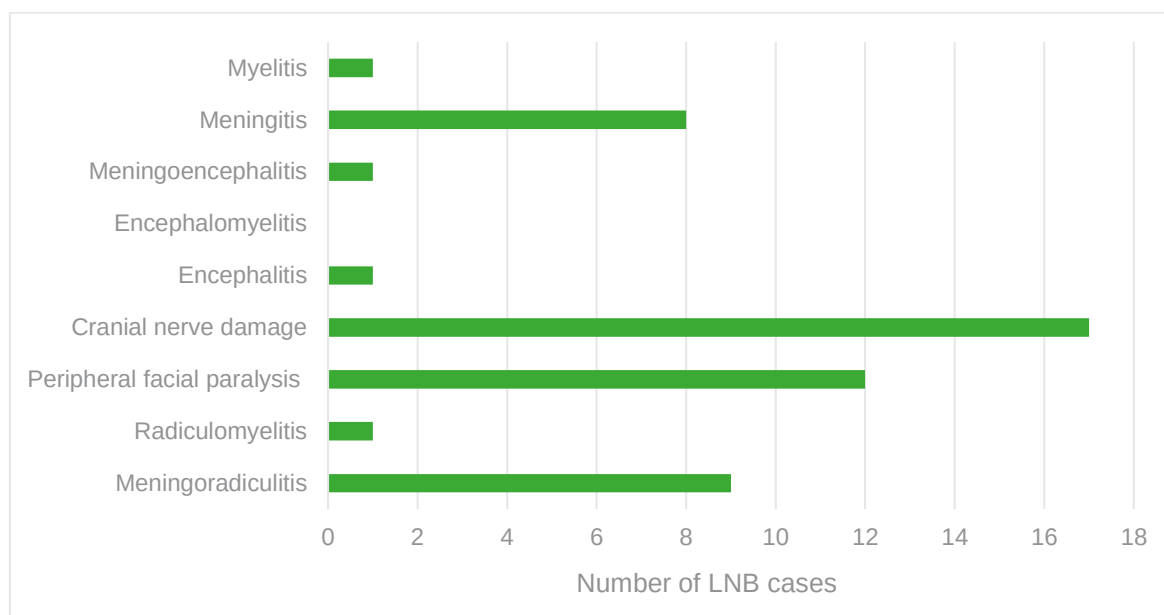
Six patients (17 %) présentait des manifestations cliniques du système nerveux central (SNC), 18 (51 %) du système nerveux périphérique (SNP) et 11 (31 %) une combinaison des deux. La manifestation clinique la plus fréquemment observée était l'atteinte des nerfs crâniens (n = 17), suivie d'une paralysie faciale périphérique (n = 12) (Figure 6).

Vingt-et-un cas (60 %) ont reçu un traitement antibiotique par voie intraveineuse, quatre cas (11 %) ont reçu un traitement par voie orale et sept cas (20 %) ont reçu une combinaison des deux. Pour trois cas, l'information n'était pas connue.

Vingt-neuf patients ont été hospitalisés (83 %) et un patient a été admis aux soins intensifs. Aucun patient n'est décédé.

³ Plusieurs tests peuvent avoir été effectués pour un même patient.

Figure 6 : Manifestations cliniques de la NBL observées, 2025⁴



⁴ Plusieurs manifestations cliniques ont pu être observées chez un même patient.

3.3. Encéphalite à tiques

En 2025, trois cas d'encéphalite à tique ont été rapportés, provenant respectivement d'un hôpital en Wallonie, d'un hôpital à Bruxelles et d'un hôpital en Flandre. Il s'agissait de deux femmes appartenant au groupe d'âge 25-44 ans et d'un homme âgé de plus de 65 ans. Deux patients ont été infectés à la suite d'une morsure de tique dans la Forêt-Noire (Allemagne). Le troisième patient a été contaminé par voie alimentaire en France. Les trois patients ont été hospitalisés sans admission en unité de soins intensifs, et aucun n'est décédé. Ces trois cas ont également été rapportés par le Centre National de Référence (Institut de Médecine Tropicale).

3.4. Paralysie flasque aiguë

Quatre cas de PFA ont été signalés en 2025, par trois hôpitaux différents, dans les trois régions. Les cas ont été signalés en janvier, février, avril, et juin. Deux cas seulement (50 %) étaient âgés de moins de 15 ans (un garçon et une fille). Aucun test de diagnostic en laboratoire n'a été effectué pour exclure la poliomyélite (deux échantillons de selles prélevés à 24 heures d'intervalle), comme cela est recommandé. Un cas a été signalé à l'autorité régionale (par le biais de la déclaration obligatoire) tandis que pour l'autre cas, l'information était inconnue.

Discussion

Ce rapport annuel présente les résultats de la deuxième année de surveillance du réseau NeuroSurv en Belgique. Suite à une nouvelle sensibilisation des neurologues via un email de rappel envoyé à tous les hôpitaux avec un service de neurologie et de neurologie pédiatrique, et une présentation du réseau lors de conférences, trois nouveaux hôpitaux ont accepté de participer en 2025, portant le nombre total de services participants à 51. Cependant, le taux global de participation (46 %) était plus faible qu'en 2024 (55 %), avec un nombre moyen de participants par mois de 23. Ceci est dû surtout à une participation très faible pendant les mois de septembre et décembre, sans explication particulière.

Malgré une participation générale plus faible, il y a eu plus de cas de neuroborréliose de Lyme (NBL) rapportés en 2025, avec 35 cas comparé à 25 cas en 2024. Les données préliminaires⁵ d'autres sources de surveillance de la borréliose de Lyme, comme notamment le réseau des médecins généralistes vigies, montrent également un nombre plus élevé de cas en 2025 comparé aux années précédentes. Ceci est cohérent avec les résultats de la surveillance des morsures de tiques via TiquesNet cette année-là, où le nombre de morsures rapportées était supérieur à la moyenne des trois dernières années (2022-2024) et plutôt comparable aux années précédentes (13).

Parmi les 35 cas de NBL, 27 (77 %) répondaient aux critères de la définition de cas probable ou confirmé pour être déclarés à l'ECDC. Ceci est une augmentation comparé à la proportion en 2024 (60 %). Comme il s'agit de petits nombres issus de deux années seulement, la comparaison doit être interprétée avec précaution, mais cela pourrait indiquer qu'il y a une plus grande adhérence aux recommandations pour le diagnostic de la NBL par les cliniciens participants. Toutefois, le nombre de cas rapporté représente toujours une sous-estimation importante du fardeau de maladie réelle attendue de la NBL en Belgique (estimation annuelle de 270 cas (6)), en raison de plusieurs facteurs (réseau non exhaustif, participation mensuelle faible et/ou irrégulière, pas tous les cas de NBL sont diagnostiqués par un neurologue ou un neurologue pédiatrique, ...).

En plus des cas de NBL, il y a également eu trois cas de TBE et quatre cas de PFA rapportés, comparé à un cas et dix cas respectivement en 2024. Les données préliminaires⁵ pour la TBE en 2025 montrent également un nombre de cas plus élevé enregistré via les autres sources de surveillance (CNR des arbovirus et déclaration obligatoire en Flandre), aussi bien pour les cas importés qu'autochtones. Ceci est également cohérent avec un nombre plus élevé de morsures de tiques cette année-là (voir plus haut). Pour la PFA, le nombre de cas rapportés en 2025 est également resté faible et inférieur au nombre de cas déclarés dans le cadre de la déclaration obligatoire (n = 6 chez des enfants de < 15 ans).

Malgré certaines limites, NeuroSurv a permis, pour la deuxième année consécutive, de transmettre des données sur la NBL en Belgique à l'ECDC (ce qui est une obligation européenne) et d'impliquer davantage des médecins dans la surveillance de maladies infectieuses en Belgique. L'objectif est de continuer de consolider le réseau ainsi que d'améliorer la qualité des données.

À partir de 2026, la collecte de données pour la NBL évoluera d'un système agrégé vers une collecte de données individuelles de cas. Cela permettra un rapport plus complet des données à l'ECDC. Pour limiter la charge de travail pour les participants, il a été décidé de limiter la surveillance à la NBL, et de poursuivre la collecte des données sur la TBE et la PFA uniquement via les autres systèmes de surveillance. Néanmoins, en fonction de la situation épidémiologique, d'autres maladies pertinentes pourraient également être ajoutées à la surveillance dans le futur. Ainsi, dans le contexte d'une circulation du virus du Nil-occidental en Belgique chez des oiseaux démontrée pour la première fois en août 2025 (14), une surveillance renforcée via NeuroSurv pourrait être pertinente. Ceci est sous discussion dans le cadre de l'élaboration d'un plan national de préparation au virus en Belgique.

⁵ Rapport en cours d'élaboration.

Références

1. van den Wijngaard CC, Hofhuis A, Simões M, Rood E, van Pelt W, Zeller H, et al. Surveillance perspective on Lyme borreliosis across the European Union and European Economic Area. *Euro Surveill Bull Eur Sur Mal Transm Eur Commun Dis Bull.* 6 Jul 2017;22(27):30569.
2. Burn L, Vyse A, Pilz A, Tran TMP, Fletcher MA, Angulo FJ, et al. Incidence of Lyme Borreliosis in Europe: A Systematic Review (2005-2020). *Vector Borne Zoonotic Dis Larchmt N.* Apr 2023;23(4):172-94.
3. BAPCOC. Borréliose de Lyme (infection à Borrelia). Disponible sur : https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/guide_borreliose_de_lyme_fr_2024_0.pdf
4. Figoni J, Chirouze C, Hansmann Y, Lemogne C, Hentgen V, Saunier A, et al. Lyme borreliosis and other tick-borne diseases. Guidelines from the French Scientific Societies (I): prevention, epidemiology, diagnosis. *Med Mal Infect.* Aug 2019;49(5):318-34.
5. Dahl V, Wisell KT, Giske CG, Tegnell A, Wallensten A. Lyme neuroborreliosis epidemiology in Sweden 2010 to 2014: clinical microbiology laboratories are a better data source than the hospital discharge diagnosis register. *Euro Surveill Bull Eur Sur Mal Transm Eur Commun Dis Bull.* May 2019;24(20):1800453.
6. Geebelen L, Van Cauteren D, Devleeschauwer B, Moreels S, Tersago K, Van Oyen H, et al. Combining primary care surveillance and a meta-analysis to estimate the incidence of the clinical manifestations of Lyme borreliosis in Belgium, 2015-2017. *Ticks Tick-Borne Dis.* Apr 2019;10(3):598-605.
7. Van Heuverswyn J, Hallmaier-Wacker LK, Beauté J, Gomes Dias J, Haussig JM, Busch K, et al. Spatiotemporal spread of tick-borne encephalitis in the EU/EEA, 2012 to 2020. *Euro Surveill Bull Eur Sur Mal Transm Eur Commun Dis Bull.* Mar 2023;28(11):2200543.
8. Lernout. sciensano.be. Surveillance épidémiologique de l'encéphalite à tiques - 2018. Disponible sur : <https://www.sciensano.be/fr/biblio/surveillance-epidemiologique-de-lencephalite-a-tiques-2018>
9. Stoefs A, Heyndrickx L, De Winter J, Coeckelbergh E, Willekens B, Alonso-Jiménez A, et al. Autochthonous Cases of Tick-Borne Encephalitis, Belgium, 2020. *Emerg Infect Dis.* Aug 2021;27(8):2179-82.
10. Linden A, Wirtgen M, Nahayo A, Heyman P, Niedrig M, Schulze Y. Tickborne encephalitis virus antibodies in wild cervids in Belgium. *Vet Rec.* Jan 2012;170(4):108.
11. Roelandt S, Suin V, Riocreux F, Lamoral S, Van der Heyden S, Van der Stede Y, et al. Autochthonous tick-borne encephalitis virus-seropositive cattle in Belgium: a risk-based targeted serological survey. *Vector Borne Zoonotic Dis Larchmt N.* Sept 2014;14(9):640-7.
12. Adjadj NR, Vervaeke M, Sohler C, Cargnel M, De Regge N. Tick-Borne Encephalitis Virus Prevalence in Sheep, Wild Boar and Ticks in Belgium. *Viruses.* Oct 2022;14(11):2362.
13. Geebelen L, Lernout T. TiquesNet. Surveillance des morsures de tiques en Belgique. Résultats en 2025. Disponible sur : https://www.sciensano.be/sites/default/files/surveillance_des_morsures_de_tiques_tiquesnet_2025_final.pdf
14. Sohler C, Breman FC, Vervaeke M, Sikkema R, Boter M, Oude Munnink B et al. First detection of West Nile virus in Belgium through wild bird surveillance, Belgium, 2025. *Euro Surveill.* 2026 Jan;31(4):2600049.

Annexe 1 – Définitions de cas

Neuroborréliose de Lyme

Source : DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/ 945 DE LA COMMISSION - du 22 juin 2018 - concernant les maladies transmissibles et les problèmes de santé particuliers connexes devant faire l'objet d'une surveillance épidémiologique ainsi que les définitions de cas pertinentes (europa.eu).

3.25. LYME NEUROBORRELIOSIS

Clinical Criteria

- Neurological symptoms according to European Federation of Neurological Societies (EFNS) suggested case definition (¹), without other obvious reasons

Laboratory Criteria

A. Confirmed case

- Pleocytosis in cerebrospinal fluid, AND
 - Evidence of intrathecal production of Lyme borreliosis antibodies, OR
 - *Borrelia burgdorferi* s.l. isolation, OR
 - nucleic acid detection in cerebrospinal fluid
- OR
- Detection of IgG Lyme borreliosis antibodies in blood specimen only for children (age under 18) with facial palsy or other cranial neuritis and a recent (< 2 months) history of erythema migrans

B. Probable case

- Pleocytosis in cerebrospinal fluid AND positive Lyme borreliosis serology in cerebrospinal fluid
- OR
- Specific intrathecal Lyme borreliosis antibody production

Epidemiological Criteria

Not applicable

Case Classification

A. Possible case

Not applicable

B. Probable case

Any person meeting the clinical criteria and at least one of the laboratory criteria for probable cases

C. Confirmed case

Any person meeting the clinical criteria and at least one of the laboratory criteria for confirmed cases

Encéphalite à tiques

Source : DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/ 945 DE LA COMMISSION - du 22 juin 2018 - relative aux maladies transmissibles et aux problèmes de santé particuliers connexes devant faire l'objet d'une surveillance épidémiologique ainsi qu'aux définitions de cas pertinentes (europa.eu).

3.46. TICK-BORNE VIRAL ENCEPHALITIS

Clinical Criteria

Any person with symptoms of inflammation of the CNS (for example, meningitis, meningo-encephalitis, encephalomyelitis, encephaloradiculitis)

Laboratory Criteria ⁽¹⁾

Laboratory criteria for case confirmation:

At least one of the following five:

- TBE specific IgM AND IgG antibodies in blood
- TBE specific IgM antibodies in CSF
- Seroconversion or four-fold increase of TBE-specific antibodies in paired serum samples
- Detection of TBE viral nucleic acid in a clinical specimen,
- Isolation of TBE virus from clinical specimen

Laboratory criteria for a probable case:

Detection of TBE-specific IgM-antibodies in a unique serum sample

Epidemiological Criteria

Exposure to a common source (unpasteurised dairy products)

Case Classification

A. Possible case NA

B. Probable case

Any person meeting the clinical criteria and the laboratory criteria for a probable case,

OR

Any person meeting the clinical criteria with an epidemiological link

C. Confirmed case

Any person meeting the clinical and laboratory criteria for case confirmation

Note: Serological results should be interpreted according to previous exposure to other flaviviral infections and the flavivirus vaccination status. Confirmed cases in such situations should be validated by serum neutralization assay or other equivalent assays.

Paralysie flasque aiguë

Source : [Surveillance des maladies infectieuses chez les enfants | PediSurv | sciensano](#).

▼ Paralysie flasque aiguë (PFA)

Tableau clinique aigu correspondant à une parésie ou paralysie flasque avec diminution du tonus sans cause apparente (telle qu'un trauma), chez un enfant de moins de 15 ans.

- Veuillez prélever 2 échantillons de selles pour tous les enfants de moins de 15 ans ayant une paralysie flasque aiguë, de façon à exclure une infection par un entérovirus/poliovirus.

Causes possibles de PFA :

- Poliomyélite antérieure aiguë causée par un poliovirus ou un autre virus neurotrope (coxsachie, echovirus ...)
- Myélopathie aiguë : myélopathie transverse idiopathique aiguë, abcès paraspinal, tumeur ou hématome
- Neuropathie périphérique
 - Syndrome de Guillain-Barré
 - Neuropathie démyélinisante aiguë
 - Neuropathie axonale aiguë
 - Post vaccin anti-rage
 - Neuropathie par maladie infectieuse (ex. : diphtérie, maladie de Lyme ...) ou intoxication par métaux lourds ou toxines
- Maladies systémiques : porphyrie intermittente aiguë
- Trouble de la transmission neuromusculaire : myasthénie grave, botulisme
- Maladies musculaires : myopathie inflammatoire idiopathique (polymyosite), trichinose, paralysie par hypokaliémie et hyperkaliémie

CONTACT

Personne de contact : Giulietta Stefani • T+32 2 642 55 00 • neurosurv@sciensano.be

À PROPOS DE SCIENSANO

Sciensano est un institut scientifique public et indépendant, qui œuvre pour la santé de l'homme et de l'animal et leur environnement.

Nous faisons de la recherche scientifique et de la surveillance et nous soutenons les autorités et différentes agences et organisations par des avis et des services et au travers de notre expertise en matière de santé.

Sciensano accorde une grande importance au principe One Health qui met en exergue que la santé de l'homme, la santé de l'animal et leur environnement sont étroitement liés.

C'est pour cette raison que notre recherche est interdisciplinaire et qu'elle intègre différentes perspectives.

Avec plus de mille collaborateurs et 120 ans d'expertise scientifique, Sciensano est un établissement scientifique de renom, qui fait partie de plusieurs réseaux scientifiques internationaux.

PLUS D'INFOS

Sciensano.be – info@sciensano.be

Rue Juliette Wytsman 14 • Bruxelles • Belgique • T + 32 2 642 51 11